

Krisenplan erstellen

Wenn die Lage bereits kippt

Wenn akute Selbst- oder Fremdgefährdung im Raum steht, nicht erst planen:
144 oder 0800 33 66 55 anrufen und den Notfallpfad aktivieren.

- 1 Zuerst nur drei Felder ausfüllen
- 2 Plan sicher ablegen und teilen
- 3 Nach jeder Episode kurz prüfen

Wenn die Vorlage zu gross wirkt: zuerst drei Felder

1 · 1 · Frühwarnzeichen

Woran merken wir früh, dass etwas kippt?

2 · 2 · Erste Kontakte

Wer wird zuerst angerufen, wenn es ernst wird?

3 · 3 · Eine Massnahme

Was hat beim letzten Mal am meisten geholfen?

Wofür ein Krisenplan da ist

Ein Krisenplan soll in belastenden Situationen Entscheidungslast reduzieren. Er ergänzt Behandlung und Notfallwege, ersetzt sie aber nicht. Er hilft nicht, jede Krise zu verhindern. Aber er macht oft früher sichtbar, wann etwas kippt, wer was übernimmt und welche Schritte dann nicht erst unter Druck erfunden werden müssen.

Wann Sie ihn erstellen sollten

Die beste Zeit für einen Krisenplan ist eine stabile Phase. Dann kann die erkrankte Person klarer denken, abwägen und mitentscheiden. Gerade Themen wie Frühwarnzeichen, Kontakte, Medikamente, Klinikwünsche oder Grenzen lassen sich dann viel besser besprechen als mitten in einer Krise.

Was zuerst hinein sollte

Beginnen Sie nicht mit dem perfekten Gesamtplan. Füllen Sie zuerst drei Felder aus: Frühwarnzeichen, erste Kontakte und die eine Massnahme, die beim letzten Mal am meisten geholfen hat. Das reicht oft, um den nächsten Schritt in einer Krise schneller zu finden.

Danach können Sie ergänzen:

- behandelnde Stellen mit Telefonnummern
- Medikamente, zuständige Behandlungspersonen und was bei Absetzen vereinbart ist; keine Dosierungen ohne Behandlungsteam ändern
- ab wann Schutz vor Gespräch geht
- Klinik- oder Aufnahme-Wünsche
- Kinderbetreuung, Alltag, Finanzen und Grenzen
- wo der ausgedruckte Plan liegt

Je konkreter die Formulierungen sind, desto hilfreicher wird der Plan später.

Wie Sie das Gespräch anfangen können

Hilfreicher als Druck ist ein ruhiger Einstieg wie:

„Wann wäre ein guter Zeitpunkt, über den Krisenplan zu reden?“

Das gibt der anderen Person Kontrolle über den Zeitpunkt zurück. Sinnvoll ist auch, pro Gespräch nur ein Thema zu klären, statt den ganzen Plan auf einmal zu erzwingen.

Was eher hilft

- einen ruhigen, bewusst gewählten Moment nutzen
- Beobachtungen statt Vorwürfe einbringen
- schriftlich festhalten, was beide Seiten meinen

- die ausgedruckte Version so ablegen, dass sie im Notfall auffindbar ist
- vereinbaren, wer den Plan im Ernstfall hervorheben darf

Datenschutz und Aufbewahrung

Ein ausgefüllter Krisenplan enthält sensible Gesundheitsdaten. Teilen Sie ihn nur mit Personen, denen beide vertrauen. Bewahren Sie Ausdrucke sicher und auffindbar auf. Speichern Sie digitale Kopien bewusst, nicht ungeschützt auf gemeinsam genutzten Geräten.

Was eher nicht hilft

- den Plan erst in der Krise erstellen wollen
- alles in einem einzigen Gespräch lösen wollen
- unklare Formulierungen wie „irgendwann Hilfe holen“

Wenn Medikamente abgesetzt wurden oder die Lage unsicher wird

Gerade dann lohnt sich ein aktualisierter Krisenplan besonders. Halten Sie fest, wer informiert wird, welche Warnzeichen ernst genommen werden und ab welchem Punkt nicht mehr diskutiert, sondern gehandelt wird. Medikamentenfragen gehören ans Behandlungsteam. Der Plan ist kein Misstrauen, sondern ein Sicherheitsnetz.

Nächster sinnvoller Schritt

Öffnen Sie das Krisenplan-Werkzeug oder nehmen Sie die PDF-Vorlage zur Hand. Wenn bereits Warnzeichen da sind, öffnen Sie zuerst den vorhandenen Plan, statt in der Akutsituation einen neuen perfekt schreiben zu wollen.

Weiterführend:

- Krisenplan-Werkzeug
- Krisenplan-Vorlage
- Modul 6: Kommunikation in stabilen und akuten Phasen
- Notfallseite

Quellen (Auswahl)

1. NICE (CG185): Bipolar disorder: assessment and management. Updated 2025-09-02. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185> · 2. NICE (NG225): Self-harm: assessment, management and preventing recurrence. Reviewed 2024-08-16. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng225> · 3. Miklowitz und Chung (2016): Family-Focused Therapy for Bipolar Disorder. Family Process. <https://doi.org/10.1111/famp.12237>